

Motif d'admission et séjour

SÉJOUR DU 23 AU 25 JUIN 2026

SÉJOUR 23 – 25 juin 2026	UNITÉ Médecine polyvalente	MODE D'ENTRÉE Urgences	MODE DE SORTIE Domicile
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------

Motif d'admission

Patiente de 64 ans adressée par les urgences pour malaise sans perte de connaissance complète, survenu à domicile le 23 juin en fin de matinée, dans un contexte de réduction des apports hydriques et de températures élevées.

Évolution pendant le séjour

Prise en charge par réhydratation prudente et surveillance du rythme et de la fonction rénale. Évolution favorable dès la première journée, avec reprise d'une alimentation normale et disparition des sensations vertigineuses. Aucun événement rythmique aigu n'a été documenté pendant le séjour.

CONSTANTES À L'ENTRÉE

TA 104/62 mmHg, FC 92/min, température 37,1 °C

CONSTANTES À LA SORTIE

TA 126/78 mmHg, FC 74/min, température 36,8 °C

POIDS À L'ENTRÉE

66,1 kg

POIDS À LA SORTIE

68,0 kg

Examen clinique à l'admission

Patiente consciente, orientée, apyrétique. Pli cutané persistant et muqueuses sèches. Auscultation cardio-pulmonaire sans anomalie nouvelle. Absence de déficit neurologique focal. Examen abdominal souple et indolore.

Éléments recueillis auprès de la patiente à l'admission

INFORMATION	DÉCLARATION À L'ADMISSION
Traitements en cours	Liste récitée par la patiente, sans ordonnance présentée
Dernière prise médicamenteuse	Matin du 23 juin
Apports hydriques des trois derniers jours	Décrits comme réduits
Épisodes similaires antérieurs	Aucun rapporté

Antécédents et allergies

PAGE 2 / 6

ANTÉCÉDENT	DEPUIS	SUIVI
Hypertension artérielle	2017	Médecin traitant
Fibrillation atriale permanente	2021	Cardiologue de ville
Dyslipidémie	2019	Médecin traitant

Rubrique allergies du dossier d'hospitalisation

ALLERGIES CONNUES : AUCUNE CONNUE
Source de l'information .. : déclaration à l'admission
Vérification dossier ville : non renseignée
Date de saisie : 23/06/2026 11:47

CHAMP À RAPPROCHER DU DOSSIER DE VILLE

La rubrique du présent compte rendu porte « aucune connue ». La note de consultation du 12 janvier 2026 documente une allergie à l'amoxicilline avec éruption en 2019. Les deux documents sont en contradiction.

Traitements administrés pendant le séjour

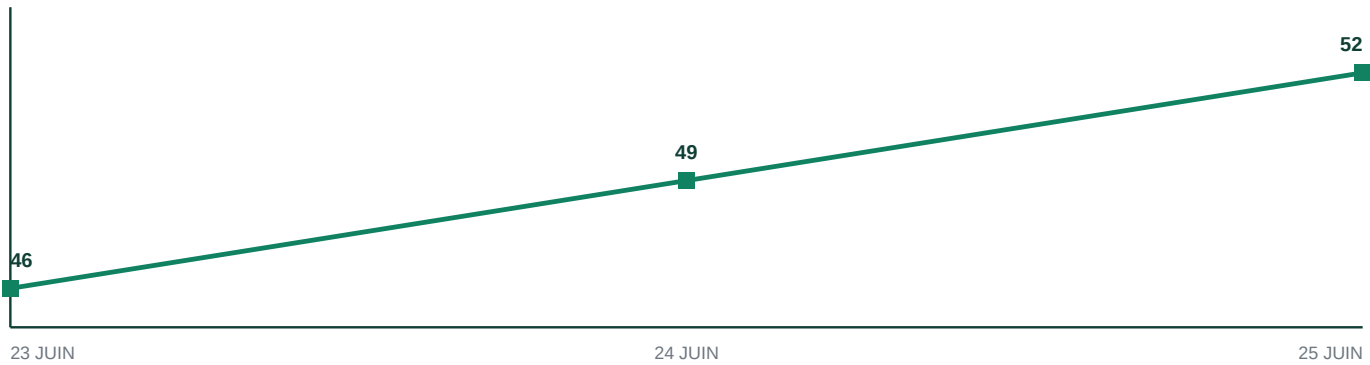
TRAITEMENT	VOIE	DURÉE
Soluté de réhydratation	Intraveineuse	23 et 24 juin
Traitement habituel poursuivi	Orale	Tout le séjour, hors ramipril
Aucun antibiotique administré	Sans objet	Sans objet

Aucun antibiotique de la famille des pénicillines n'a été administré pendant le séjour.

Examens biologiques du séjour

PAGE 3 / 6

PARAMÈTRE	23 JUIN	25 JUIN	INTERVALLE
Débit de filtration glomérulaire estimé	46 mL/min/1,73 m ²	52 mL/min/1,73 m ²	> 60
Créatinine	112 µmol/L	101 µmol/L	45 – 84
Potassium	5,1 mmol/L	4,7 mmol/L	3,5 – 5,0
Sodium	139 mmol/L	140 mmol/L	136 – 145
Hémoglobine	12,6 g/dL	12,8 g/dL	12,0 – 16,0



Évolution du débit de filtration glomérulaire pendant le séjour, en mL/min/1,73 m². La valeur du 24 juin est un contrôle intermédiaire réalisé en unité.

Autres examens du séjour

- Électrocardiogramme du 23 juin : fibrillation atriale connue, sans anomalie aiguë.
- Bandelette urinaire du 23 juin : absence de signe d'infection.
- Surveillance tensionnelle toutes les quatre heures pendant les 24 premières heures.

Aucun examen d'imagerie n'a été réalisé pendant le séjour.

Traitement de sortie

PAGE 4 / 6

MÉDICAMENT	DOSE	MOMENT	MODIFICATION PENDANT LE SÉJOUR
Rivaroxaban	20 mg	Le soir	Aucune modification tracée
Ramipril	5 mg	Le matin	Suspendu le 23 juin, repris le 25 juin
Bisoprolol	2,5 mg	Le matin	Poursuivi
Atorvastatine	20 mg	Le soir	Poursuivi

Observations sur la conciliation médicamenteuse

Le traitement de sortie a été établi à partir de la liste recueillie à l'admission. Le dossier ne comporte pas de trace d'une comparaison avec la dernière ordonnance de ville ni avec le courrier de cardiologie du 20 juin.

DIVERGENCE DOCUMENTAIRE

Le présent compte rendu indique rivaroxaban 20 mg. Le courrier de cardiologie du 20 juin fait état de 15 mg par jour. Le dossier ne permet pas d'établir laquelle de ces doses a été effectivement prise.

Source de la liste de sortie

La liste de sortie reprend la liste d'admission, corrigée de la reprise du ramipril. Le dossier ne comporte pas de fiche de conciliation médicamenteuse signée par un pharmacien.

Ordonnance de sortie

LIGNE PRESCRITE À LA SORTIE	DURÉE	RENOUVELLEMENT
Rivaroxaban 20 mg, le soir	1 mois	Selon avis du médecin traitant
Ramipril 5 mg, le matin	1 mois	Selon avis du médecin traitant
Bisoprolol 2,5 mg, le matin	1 mois	Selon avis du médecin traitant
Atorvastatine 20 mg, le soir	1 mois	Selon avis du médecin traitant
Contrôle biologique créatinine et potassium	À réaliser sous 7 jours	Sans objet

L'ordonnance de sortie est mentionnée comme remise à la patiente ; elle n'est pas jointe au dossier communiqué.

Plan de suivi après la sortie

PAGE 5 / 6

1. Contrôle de la créatinine et du potassium dans les sept jours suivant la sortie, soit au plus tard le 2 juillet 2026.
2. Consultation auprès du médecin traitant dans les dix jours, avec les résultats du contrôle.
3. Surveillance des apports hydriques quotidiens, en particulier en période de forte chaleur.
4. Reprise de contact avec le cardiologue traitant pour la question de la posologie anticoagulante.

ACTION DE SUIVI	ÉCHÉANCE	ÉLÉMENT PRÉSENT AU DOSSIER
Contrôle biologique	2 juillet 2026	Aucun résultat joint
Consultation de suivi	5 juillet 2026	Aucun compte rendu joint
Ordonnance de sortie remise	25 juin 2026	Mentionnée, non jointe au dossier
Rendez-vous de cardiologie	Non planifié	Aucune convocation au dossier

DONNÉE ABSENTE À LA DATE DE REVUE

Au 10 juillet 2026, aucun résultat du contrôle biologique demandé ne figure au dossier communiqué. L'absence est constatée, elle n'est pas interprétée.

Consignes remises à la patiente

- Consulter sans délai en cas de nouveau malaise, de vertiges ou de fatigue inhabituelle.
- Maintenir des apports hydriques réguliers, en particulier en cas de chaleur.
- Se présenter au laboratoire avec l'ordonnance de contrôle remise à la sortie.
- Conserver la liste de traitements à jour et la présenter à tout professionnel consulté.

Coordonnées utiles remises à la patiente

UNITÉ D'HOSPITALISATION

Médecine polyvalente, Hôpital des Tilleuls (fictif)

EN CAS D'URGENCE

Service d'urgence le plus proche

CRÉNEAUX D'APPEL

Du lundi au vendredi, 09 h 00 – 17 h 00

LABORATOIRE DE CONTRÔLE

Au choix de la patiente

Validation et diffusion

PAGE 6 / 6

RÉDACTEUR Dr L. Fontaine, médecine polyvalente (fictif)	VALIDATION 25 juin 2026, 16 h 10
DESTINATAIRE PRINCIPAL Médecin traitant, Cabinet Horizon Santé (fictif)	COPIE Cardiologue traitant, Centre Cardio Valmont (fictif)
REMIS À LA PATIENTE Exemplaire imprimé le jour de la sortie	PIÈCES JOINTES ANNONCÉES Ordonnance de sortie

Mentions de diffusion

Le présent compte rendu est adressé aux professionnels intervenant dans la prise en charge. Toute divergence constatée avec le dossier de ville doit faire l'objet d'une conciliation par un professionnel habilité avant toute décision.

Traçabilité de l'envoi

DESTINATAIRE	MODE D'ENVOI	DATE
Médecin traitant	Messagerie sécurisée	25 juin 2026
Cardiologue traitant	Messagerie sécurisée	25 juin 2026
Patiente	Remise en main propre	25 juin 2026

SIGNATURE DU RÉDACTEUR <i>Signature fictive de démonstration</i>	VISA DE L'UNITÉ <i>Cachet fictif</i>
---	---

Document fictif produit pour une démonstration logicielle. Aucune donnée réelle de patient n'y figure.